

Résumé des caractéristiques du produit

1.1 Nom du médicament

a. Nom du produit

AARCOLD (comprimés de paracétamol, chlorhydrate de phényléphrine, cétirizine et maléate de chlorphénamine)

b. Dosage

325 mg + 5 mg + 5 mg + 2 mg

c. Forme galénique pharmaceutique

Comprimé pour administration orale

1.2 Composition quantitative et qualitative

Chaque comprimé non enrobé contient :

Paracétamol BP325 mg
Chlorhydrate de phényléphrine BP..... 5 mg
Cétirizine BP..... 5 mg
Maléate de chlorphénamine BP2 mg
Excipients..... q.s.

1.3 Forme pharmaceutique : Comprimé

Description visuelle : Comprimé biconvexe non couché de forme ronde de couleur orange clair

1.4 Particularités cliniques

a. Indication thérapeutique

AARCOLD en comprimé est indiqué pour le traitement des symptômes associés à la grippe, au rhume et à la sinusite. Il est indiqué pour le soulagement de la douleur, de la fièvre, du nez qui coule, des éternuements et de la congestion nasale associés à la grippe et au rhume.

b. Posologie et mode d'administration

Selon les directives du médecin.

c. Contre-indication

Hypersensibilité à l'un des ingrédients de la formulation. Ne pas utiliser en vente libre chez les enfants de moins de 2 ans. Le produit est contre-indiqué chez les patients souffrant d'asthme bronchique, d'hypertension grave, de coronaropathie sévère, de glaucome à angle fermé, de rétention urinaire, d'ulcère gastroduodénal, de tachycardie ventriculaire et chez les patients traités par des inhibiteurs de MAO.

Le paracétamol doit être administré avec prudence aux patients qui prennent d'autres médicaments qui affectent le foie.

d. Avertissement spécial et précautions d'emploi

Avertissements

En raison de son composant antihistaminique, le maléate de chlorphétamine contenu dans le comprimé AARCOLD doit être utilisé avec prudence chez les patients ayant des antécédents d'asthme bronchique, d'obstruction gastro-intestinale ou d'obstruction de la vessie. En raison de sa composante sympathomimétique, le Chlorhydrate de phényléphrine en comprimés AARCOLD doit être utilisé judicieusement et avec parcimonie chez les patients souffrant d'hypertension, de diabète, de maladie cardiaque, d'augmentation de la pression intraoculaire, d'hyperthyroïdie ou d'hypertrophie prostatique.

Les antihistaminiques peuvent provoquer de la somnolence ou de l'excitation, en particulier chez les enfants et les personnes âgées. NE PAS DÉPASSER LA DOSE RECOMMANDÉE. Étant donné que la phénylphrine est un agent adrénérgique, elle doit être administrée avec prudence aux patients atteints de maladies thyroïdiennes, de diabète sucré et de maladies cardiaques ou qui reçoivent des antidépresseurs tricycliques. Les hommes présentant une hypertrophie bénigne et symptomatique de la prostate peuvent présenter une rétention urinaire lorsqu'on leur administre des décongestionnants nasaux oraux. La phénylphrine peut entraîner une diminution du débit cardiaque et il faut faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'on administre le médicament par voie parentérale ou orale à des patients atteints d'artériosclérose, à des personnes âgées et/ou à des patients dont la circulation cérébrale ou coronarienne était initialement mauvaise.

Il faut faire preuve de prudence lorsqu'on conduit un véhicule, qu'on utilise une machine ou qu'on exerce d'autres activités dangereuses. Paracétamol/Chlorphénamine/Phénylphrine peut causer des étourdissements ou de la somnolence. L'alcool doit être utilisé avec prudence. L'alcool et le paracétamol peuvent également être nocifs pour le foie.

Cétirizine contenu dans AARCOLD comprimé aux doses thérapeutiques, aucune interaction cliniquement significative n'a été démontrée avec l'alcool (pour un taux d'alcoolémie de 0,5 g/L). Néanmoins, la prudence est recommandée en cas de consommation concomitante d'alcool.

e. Interaction avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions

Cas de la chlorphénamine

Médicaments inhibiteurs de l'acétylcholinestérase : La prise de Chlorphénamine avec un inhibiteur de l'acétylcholinestérase peut rendre les deux médicaments moins efficaces.

Médicaments anticholinergiques : Combinaison d'un médicament anticholinergique avec de la chlorphénamine (qui a des effets anticholinergiques) peut augmenter le risque d'effets secondaires de la chlorphénamine, comme la sécheresse oculaire ou la difficulté à uriner.

Inhibiteur de la monoamine oxydase (IMAO) : La prise simultanée de chlorphénamine et d'un IMAO peut prolonger et intensifier certains effets secondaires de la chlorphénamine (comme la somnolence, la sécheresse ou la difficulté à uriner).

Autres médicaments qui causent la somnolence : combiner la chlorphénamine avec tout autre médicament qui cause également la somnolence, comme effets secondaires indésirables (comme la somnolence excessive, les étourdissements ou la confusion).

Phénothiazine : La chlorphénamine peut augmenter le risque d'arythmie cardiaque dangereuse due à un médicament à base de phénothiazine. De plus, la combinaison de chlorphénamine avec une phénothiazine augmente le risque de somnolence excessive.

Pramlintide : Le pramlintide et les médicaments anticholinergiques (y compris la chlorphénamine) peuvent ralentir le mouvement des aliments dans le tube digestif.

Cas de la phénylphrine :

Inhibiteurs de la monoamine oxydase (MAIO) ou antidépresseurs tricycliques et une crise sympathomimétique: hypersensitive indirecte ou mixte.

Des alcaloïdes de l'ergot de seigle : Augmentation excessive de la tension artérielle.

Propranolol ou bêta-bloquants adrénérgiques : Les effets cardiostimulants sont bloqués.

Sympathomimétiques : Une tachycardie ou des arythmies peuvent survenir.

Sulfate d'atropine : La bradycardie réflexe est bloquée, la réponse du presseur est améliorée.

Phentolamine : Réponse du presseur réduite.

Cas du paracétamol :

La vitesse d'absorption du paracétamol peut être augmentée par le métoclorpramide ou la dompéridone. Il n'est pas nécessaire d'éviter l'utilisation concomitante. L'absorption du Paracetamol peut éventuellement être

réduite si la Cholestyramine est administrée en même temps. L'effet anticoagulant de la warfarine et d'autres coumarines peut être renforcé par l'utilisation régulière prolongée de paracétamol avec un risque accru de saignement.

A cas de la Cétirizine

En raison du profil pharmacocinétique, pharmacodynamique et de tolérance de la cétirizine, aucune interaction n'est prévue avec cet antihistaminique. En fait, aucune interaction pharmacodynamique ou pharmacocinétique significative n'a été signalée dans les études sur les interactions médicamenteuses effectuées, notamment avec la pseudoéphédrine ou la théophylline (400 mg/jour).

Le degré d'absorption de la cétirizine n'est pas réduit avec les aliments, bien que le taux d'absorption soit diminué.

f. Grossesse et allaitement

Les études sur le maléate de chlorphénamine chez le lapin et le rat à des doses allant jusqu'à 50 fois et 85 fois la dose humaine, respectivement, n'ont révélé aucun signe d'effets nocifs sur le fœtus. L'administration de phényléphrine à des patientes en fin de grossesse ou d'accouchement peut provoquer une anoxie fœtale ou une bradycardie en augmentant la contractilité de l'utérus et en réduisant la circulation sanguine utérine. Le paracétamol est considéré comme sécuritaire pour la consommation pendant la grossesse.

Il n'existe cependant pas d'études adéquates et bien contrôlées chez les femmes enceintes. Parce que les études sur la reproduction animale ne sont pas toujours prédictives de la réponse humaine. AARCOLD en comprimé ne doit être utilisé pendant la grossesse qu'en cas de nécessité évidente.

On ne sait pas si tous les ingrédients contenus dans les comprimés AARCOLD - maléate de chlorphénamine, chlorhydrate de phényléphrine et paracétamol sont excrétés dans le lait humain. Étant donné que de nombreux médicaments sont excrétés dans le lait maternel et que ce produit peut entraîner des réactions indésirables graves chez les nourrissons qui allaitent, il faut prendre une décision à partir de médicaments apparentés, le maléate de chlorphénamine peut passer dans le lait maternel. L'utilisation n'est pas recommandée en raison du risque d'effets indésirables, comme l'irritabilité ou l'irritabilité inhabituelles, surtout chez les nourrissons. La phényléphrine peut passer dans le lait maternel et affecter un bébé allaité. Par conséquent, il n'est pas recommandé d'utiliser ce médicament sans avoir consulté un médecin au préalable. Le paracétamol est excrété dans le lait en petites quantités, bien qu'il soit considéré comme sécuritaire pour l'allaitement.

Pour la cétirizine, on dispose de très rares données cliniques sur les grossesses exposées. Les études sur les animaux n'indiquent aucun effet nocif direct ou indirect sur la grossesse, le développement embryonnaire/foetal, la parturition ou le développement postnatal. Il faut faire preuve de prudence lorsqu'on prescrit ce médicament aux femmes enceintes.

Utilisation chez les nouveau-nés, les nourrissons et les enfants :

L'innocuité et l'efficacité chez les enfants de moins de 2 ans n'ont pas été établies. Chez les nourrissons et les enfants, en particulier, les antihistaminiques en surdose peuvent causer des hallucinations, des convulsions ou la mort. Comme chez les adultes, les antihistaminiques peuvent diminuer la vigilance méthylique chez les enfants. Chez le jeune enfant, en particulier, ils peuvent produire de l'excitation.

Utilisation chez les personnes âgées (environ 60 ans ou plus) : Les antihistaminiques sont plus susceptibles de causer des étourdissements, la sédation et l'hypotension chez les patients âgés.

Maladie concomitante : Doit être prescrit avec prudence aux patients atteints d'une maladie hépatique ou d'insuffisance respiratoire.

g. Effets indésirables

Le comprimé AARCOLD est généralement bien toléré lorsqu'il est pris à la dose prescrite.

Maléate de chlorphénamine : Une somnolence légère à modérée peut survenir et constitue l'effet secondaire le plus fréquent. D'autres effets secondaires possibles des antihistaminiques en général comprennent : Urticaire, éruption cutanée, choc anaphylactique, photosensibilité, transpiration excessive, frissons, sécheresse de la bouche, du nez et de la gorge.

Cardiovasculaire : Hypotension, maux de tête, palpitations, tachycardie, extrasystoles.

Hématologique : Anémie hémolytique, thrombocytopénie, agranulocytose.

SNC : Sédation, étourdissements, troubles de la coordination, convulsion de fatigue, agitation, excitation, nervosité, tremblements, irritabilité, insomnie, euphorie, paresthésie, vision trouble, diplopie, vertige, acouphène, hystérie, névrite, convulsion.

Gastro-intestinal : Troubles épigastriques, anorexie, nausées, vomissements, diarrhée, constipation.

Génito-urinaire : Fréquence urinaire, difficulté à uriner, rétention urinaire, règles précoces.

Respiratoire : Épaississement des sécrétions bronchiques, oppression thoracique, respiration sifflante et congestion nasale.

Chlorhydrate de phényléphrine : Les rapports les plus fréquents concernaient la peau et les tissus sous-cutanés avec urticaire, œdème du visage et éruption cutanée. Les autres événements les plus fréquents étaient la rétention urinaire, le bronchospasme, la sédation et la diarrhée. Aucun cas d'accident vasculaire cérébral ou d'infarctus du myocarde n'a été signalé. Deux cas d'hypertension et un cas d'hypertension aggravée ont été signalés.

Système nerveux central - Agitation, anxiété, nervosité et étourdissements.

Cardiovasculaire - Hypertension artérielle

Autres - Douleurs primordiales, détresse respiratoire, tremblements et faiblesse.

Paracétamol : Les effets indésirables sont rares, mais une hypersensibilité, y compris une éruption cutanée, peut survenir.

Cétirizine : Des études cliniques ont démontré que la cétirizine à la posologie recommandée a des effets indésirables mineurs sur le SNC, notamment la somnolence, la fatigue, les étourdissements et les maux de tête. Dans certains cas, une stimulation paradoxale du SNC a été signalée.

Bien que la cétirizine soit un antagoniste sélectif des récepteurs H1 périphériques et qu'elle soit relativement exempte d'activité anticholinergique, des cas isolés de difficulté à mictionner, de troubles de l'accommodation oculaire et de sécheresse de la bouche ont été signalés.

h. Surdosage et antidotes spéciaux

Chlorphénamine : Surdosage : Les symptômes peuvent être: sédation, apnée, collapsus cardiovasculaire à la stimulation, insomnie, hallucinations, tremblements ou convulsions. Il peut également y avoir des étourdissements, des acouphènes, de l'ataxie, une vision trouble, de l'hypotension, une sécheresse de la bouche, des bouffées de chaleur et des symptômes abdominaux.

Traitement : Un lavage gastrique peut être nécessaire en utilisant du charbon actif et du sérum physiologique. Les cathartiques hyperosmotiques comme le lait de magnésie peuvent accélérer l'élimination ou l'adhérence résiduelle. Les vasopresseurs peuvent être utilisés pour corriger l'hypotension. Le diazépam peut être utilisé pour maîtriser les convulsions. L'hyperpyrexie peut être traitée avec des éponges froides ou une couverture hypothermique. Il n'est habituellement pas recommandé de provoquer des vomissements en cas de surdosage de chlorphénamine. Le traitement peut également comprendre des soins de soutien, qui consistent à traiter les symptômes qui surviennent à la suite du surdosage.

Phényléphrine : Les symptômes du surdosage de phényléphrine comprennent une fatigue extrême, de la transpiration, des étourdissements, un rythme cardiaque lent, le coma, l'hypertension, des maux de tête, des convulsions, une hémorragie cérébrale et des vomissements. Des battements prématurés du ventricule et de courts paroxysmes de tachycardie ventriculaire peuvent également survenir. Le traitement doit être symptomatique.

Paracétamol : En cas de surdosage aigu d'acétaminophène, l'effet indésirable le plus grave est une nécrose hépatique potentiellement mortelle et liée à la dose. Une nécrose tubulaire rénale, un coma hypoglycémique et une thrombocytopénie peuvent également survenir.

Les premiers symptômes suivant un surdosage potentiellement hépatotoxique peuvent comprendre : nausées, vomissements, diaphorèse et malaises généraux.

Traitement : L'estomac doit être vidé rapidement par lavage ou par induction de vomissements avec du sirop d'ipéca. Il est notoire que les estimations des patients quant à la quantité d'un médicament ingéré ne sont pas fiables. Par conséquent, si l'on soupçonne un surdosage d'acétaminophène, il faut obtenir un dosage sérique d'acétaminophène le plus tôt possible, mais au plus tôt quatre heures après ingestion. Les études de la fonction hépatique doivent être obtenues au départ et répétées à intervalles de 24 heures.

L'antidote, la N-acétylcystéine, doit être administré le plus tôt possible, de préférence dans les 16 heures suivant l'ingestion du surdosage pour des résultats optimaux, mais en tout état de cause, dans les 24 heures. Après la récupération, s'assurer qu'il n'y a aucune anomalie hépatique structurelle ou fonctionnelle résiduelle.

Cétirizine : Les symptômes observés après un surdosage de cétirizine sont principalement associés à des effets sur le SNC ou à des effets qui pourraient suggérer un effet anticholinergique. Les effets indésirables signalés après un apport d'au moins 5 fois la dose quotidienne recommandée sont : confusion, diarrhée, étourdissements, fatigue, maux de tête, malaise, mydriase, prurit, agitation, agitation, sédation, somnolence, stupeur, tachycardie, tremblements et rétention urinaire.

Traitement : Il n'existe aucun antidote spécifique connu à la cétirizine. En cas de surdosage, un traitement symptomatique ou de soutien est recommandé. Un lavage gastrique devrait être envisagé après l'ingestion d'un produit de courte durée. Vous pouvez aussi envisager le charbon actif.

La cétirizine n'est pas éliminée efficacement par dialyse.

1.5 Propriétés pharmacologiques Particularités cliniques

a. Propriétés pharmacodynamiques

Le maléate de chlorphénamine, un dérivé d'alkylamine, est un antihistaminique sédatif qui provoque un degré modéré de sédation, il a également une activité anti muscarinique. Il est considéré comme l'un des plus efficaces et des moins toxiques des antagonistes de l'histamine. Ces médicaments antagonisent de façon compétitive les effets de l'histamine sur les récepteurs H1 dans le tractus gastro-intestinal, l'utérus, les gros vaisseaux sanguins et les muscles lisses bronchiques. Le blocage des récepteurs H1 supprime également la formation d'œdème, d'éruptions et de prurit résultant de l'activité histaminique. L'activité anticholinergique des dérivés de la propylamine tels que la chlorphénamine est modérée. Les effets sédatifs de la Chlorphénamine résultent de l'antagonisme des récepteurs histaminergiques centraux.

Le Chlorhydrate de phényléphrine est sympathomimétique avec des effets principalement directs sur les récepteurs adrénergiques. C'est un puissant stimulateur alpha-adrénergique à action directe et à activité bêta-adrénergique. Il a une activité principalement alpha-adrénergique et n'a pas d'effets stimulants significatifs sur le SNC aux doses habituelles. Son activité vasopressive est plus faible que celle de la noradrénaline mais de plus longue durée. Elle provoque une vasoconstriction des artéioles de la muqueuse nasale et de la conjonctive. Il est utilisé comme décongestionnant pour le soulagement temporaire de la congestion nasale causée par le rhume des foins, les allergies, le rhume, l'infection des sinus ou d'autres maladies respiratoires supérieures. Les décongestionnants agissent sur les récepteurs adrénergiques des

voies nasales et rétrécissent les vaisseaux sanguins. Cette action a pour effet de soulager la sensation de congestion nasale. L'utilisation de décongestionnants favorise le drainage nasal et sinusal.

Le paracétamol (acétaminophène) est un dérivé du para-aminophénol. Il a des actions analgésiques, antipyrétiques et faiblement anti-inflammatoires. L'acétaminophène est un analgésique à action périphérique. Elle produit l'analgésie par élévation du seuil de douleur et l'antipyrèse par action sur le centre hypothalamique calorifique. Le mécanisme de l'action analgésique n'a pas été entièrement déterminé.

Le paracétamol peut agir principalement en inhibant la synthèse des prostaglandines dans le système nerveux central (SNC) et, dans une moindre mesure, par une action périphérique en bloquant la production d'impulsions de douleur. L'action périphérique peut également être due à l'inhibition de la synthèse des prostaglandines ou à l'inhibition de la synthèse ou de l'action d'autres substances qui sensibilisent les récepteurs de la douleur à la stimulation mécanique ou chimique.

Le paracétamol produit probablement une antipyrèse en agissant sur le centre hypothalamique de régulation de la chaleur pour produire une vasodilatation périphérique entraînant une augmentation du flux sanguin à travers la peau, la transpiration et la perte de chaleur. L'action centrale implique probablement l'inhibition de la synthèse des prostaglandines dans l'hypothalamus.

Cétirizine : un métabolite humain de l'hydroxyzine, est un antagoniste puissant et sélectif des récepteurs H1 périphériques... Les études in vitro de liaison aux récepteurs n'ont montré aucune affinité mesurable pour d'autres récepteurs que les récepteurs H1.

En plus de son effet anti-H1, la cétirizine a montré une activité anti-allergique : à la dose de 10 mg une à deux fois par jour, elle inhibe le recrutement tardif des éosinophiles, dans la peau et la conjonctive des sujets atopiques soumis à un défi allergène.

Des études chez des volontaires sains ont montré que la cétirizine, à des doses de 5 et 10 mg, inhibe fortement les réactions de wheal et de flare induites par des concentrations très élevées d'histamine dans la peau, mais la corrélation avec l'efficacité n'est pas établie.

Dans une étude de 35 jours menée chez des enfants âgés de 5 à 12 ans, aucune tolérance à l'effet antihistaminique (suppression de la wheal et de la poussée) de la cétirizine n'a été observée. Lorsqu'un traitement à la cétirizine est arrêté après des administrations répétées, la peau retrouve sa réactivité normale à l'histamine en 3 jours.

Dans une étude de six semaines, contrôlée par placebo, menée auprès de 186 patients souffrant de rhinite allergique et d'asthme léger à modéré concomitant, la cétirizine 10 mg une fois par jour a amélioré les symptômes de rhinite et n'a pas modifié la fonction pulmonaire. Cette étude appuie l'innocuité de l'administration de la cétirizine aux patients allergiques souffrant d'asthme léger à modéré.

Dans une étude contrôlée par placebo, la cétirizine administrée à la dose quotidienne élevée de 60 mg pendant sept jours n'a pas entraîné un allongement statistiquement significatif de l'intervalle QT.

Aux doses recommandées, la cétirizine a démontré qu'elle améliore la qualité de vie des patients souffrant de rhinite allergique saisonnière et vivace.

b. Propriétés pharmacocinétiques

Paracétamol

Absorption

Le paracétamol est facilement absorbé par le tractus gastro-intestinal.

Distribution

Les concentrations plasmatiques maximales sont atteintes environ 10 à 60 minutes après l'administration orale. Le paracétamol est distribué dans la plupart des tissus de l'organisme. Il traverse le placenta et est présent dans le lait maternel. La liaison aux protéines plasmatiques est négligeable aux concentrations thérapeutiques habituelles, mais elle augmente avec l'augmentation des concentrations.

Biotransformation

Il est métabolisé dans le foie. Un métabolite hydroxylé mineur qui est habituellement produit en très petites quantités par des oxydases à fonctions mixtes dans le foie et qui est habituellement détoxifié par

conjugaison avec le glutathion hépatique peut s'accumuler après un surdosage de paracétamol et causer des lésions tissulaires.

Élimination

Il est excrété dans l'urine, principalement sous forme de glucuronide et de sulfate conjugué. La demi-vie d'élimination varie d'environ 1 à 4 heures.

Maléate de chlorphénamine

La chlorphénamine est bien absorbée par le tractus gastro-intestinal après administration orale. Les effets se développent en 30 minutes, sont maximaux en 1 à 2 heures et durent 4 à 6 heures. La demi-vie plasmatique a été estimée entre 12 et 15 heures.

La chlorphénamine est métabolisée en dérivés monodesméthyles et didesméthyles. Environ 22 % de la dose orale est excrétée sous forme inchangée dans l'urine.

Chlorhydrate de phényléphrine

La phényléphrine est facilement absorbée après administration orale, mais elle est sujette à un métabolisme présystémique important, dont une grande partie se produit dans les entérocytes. Par conséquent, la biodisponibilité systémique n'est que d'environ 40 %. Après administration orale, les concentrations plasmatiques maximales sont atteintes en 1 à 2 heures. La demi-vie moyenne du plasma est de l'ordre de 2 à 3 heures. La pénétration dans le cerveau semble minime.

Après absorption, le médicament est largement métabolisé dans le foie. La phényléphrine et ses métabolites sont excrétés dans l'urine.

Le volume de distribution se situe entre 200 et 500 litres, mais on ne dispose d'aucune donnée sur l'étendue de la liaison aux protéines plasmatiques.

Cétirizine

La phényléphrine est facilement absorbée après administration orale, mais elle est sujette à un métabolisme pré systémique important, dont une grande partie se produit dans les entérocytes. Par conséquent, la biodisponibilité systémique n'est que d'environ 40 %. Après administration orale, les concentrations plasmatiques maximales sont atteintes en 1 à 2 heures. La demi-vie moyenne du plasma est de l'ordre de 2 à 3 heures. La pénétration dans le cerveau semble minime.

Après absorption, le médicament est largement métabolisé dans le foie. La phényléphrine et ses métabolites sont excrétés dans l'urine.

Le volume de distribution se situe entre 200 et 500 litres, mais on ne dispose d'aucune donnée sur l'étendue de la liaison aux protéines plasmatiques.

1.6 Particularités pharmaceutiques

a. Liste des excipients

1	Amidon de maïs BP
2	Silice colloïdale anhydre BP
3	Stéarate de magnésium BP
4	Talc purifié BP
5	Glycolate d'amidon sodique BP
6	Eau purifiée BP
7	Crosscarmellose sodique BP
8	Cellulose microcristalline
9	Couleur de soleil jaune

b. Incompatibilités

Aucun

PINNACLE LIFE SCIENCE PVT. LTD.
AARCOLD TABLETS

Résumé des caractéristiques du produit

(PARACÉTAMOL, CHLORHYDRATE DE PHÉNYLÉPHRINE, CETIRIZINE ET MALÉATE DE CHLORPEHNAMINE
COMPRIME)

c. Durée de vie

36 mois

Durée de vie après dilution ou reconstitution selon les instructions.

Non applicable

Durée de conservation : ouvrir d'abord le récipient.

Non applicable

d. Précautions particulières pour le stockage

Entreposer à une température inférieure à 30°C. Protéger de la lumière.

e. Nature et contenu du récipient

Blister Alu-Alu de 4 comprimés. Ce blister Alu-Alu est emballé dans un carton imprimé avec l'insert d'emballage. 25 paquets dans le carton extérieur

1.7 Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

Pinnacle Life Science Pvt. Ltd.

Mahendra Industrial Estate, 3rd Floor

Plot no .109-D, Rd no 29

Sion (East), Mumbai 400 022, INDIA

1.8 Numéro d'autorisation de mise sur le marché :

MNB/08/729

1.9 Nom du fabricant :

Pinnacle Life Science Pvt. Ltd.

Khasra No. 1328-1330, Village Manpura, Tehsil-Baddi,

Distt. Solan, Himachal Pradesh (H.P.) - 174101, Inde.

1.10 Date de la première autorisation/ renouvellement de l'autorisation

20-13-2014

1.11 Date de la révision du texte

21 octobre 2021